Formato de Entrevista Semiestructurada

Población objetivo: Fisioterapeutas con experiencia en neurorrehabilitación y manejo de Parkinson.

Modalidad: Presencial o virtual.

Duración estimada: 15 a 25 minutos.

Gracias por participar. El objetivo de esta entrevista es conocer su experiencia, necesidades y recomendaciones para diseñar un material de intervención (guía para fisioterapeutas) orientado a prevenir caídas en personas con Parkinson en fase temprana. La información será usada con fines académicos y se tratará de forma confidencial.

Comentado [A1]: En este apartado se puede incluir el consentimiento informado de quien participa de manera voluntaria aceptando responder o no la entrevista.

Datos del profesional (Breve):

- Años de experiencia. _____
- Nivel de formación. _____
- Área de servicio. _____
- Tipo de pacientes que atiende (ambulatorio u hospitalario). _____

Comentado [A2]: Puede organizarse en un forms en caso de no tener disponibilidad de hablar con las entrevistadas o entrevistados y de esta forma la información también se puede almacenar. Considero que faltan otros datos como sexo, edad, fecha de diligenciamiento.

Cuestionario Principal y Sondeos de Apoyo

1. Perfil clínico y riesgo: ¿Cuáles son los factores o situaciones más frecuentes que usted observa en Parkinson en fase temprana que aumentan el riesgo de caídas?

Comentado [A3]: Esta pregunta no creo que deba tenerse en cuenta.

_____
_____
_____
_____
_____

Preguntas de apoyo (solo si es necesario profundizar):

¿En qué actividades de la vida diaria suelen ocurrir más los tropiezos?

_____
_____

¿Cuáles son esas alertas significativas que le hacen pensar que un paciente ya está empezando a estar en riesgo?

¿Qué signos nota primero: alteraciones en la marcha, problemas con la doble tarea o rigidez?

2. Valoración y seguimiento: Desde su experiencia, ¿qué valoración funcional considera indispensable para identificar el riesgo de caída y monitorear los cambios en estos pacientes?

Preguntas de apoyo (solo si es necesario profundizar):

¿Cuáles son las pruebas específicas que usa con más frecuencia (ej. equilibrio, marcha, miedo a caer)?

¿Qué criterios clínicos utiliza para clasificar si el riesgo es bajo, medio o alto?

¿Con qué periodicidad recomendaría reevaluar?

3. Componentes de la intervención: Si tuviera que priorizar componentes de intervención para prevenir caídas en la fase temprana, ¿cuáles incluiría en su plan de tratamiento y por qué?

Preguntas de apoyo (solo si es necesario profundizar):

¿Qué opina del entrenamiento en doble tarea o el uso de estímulos (cues) auditivos y visuales?

Comentado [A4]: Considero que desde aquí puede iniciar la entrevista,

Comentado [A5]: De las preguntas de apoyo, dejar solo dos con el fin de despejar dudas.

Comentado [A6]: Esta no me parece que se deba incluir, revisar las otras porque son más como preguntas tipo examen. Usted puede cambiar la pregunta de valoración de la siguiente manera, ¿cuáles aspectos de la evaluación son indispensables para la intervención en la prevención de caídas en pacientes con Parkinson en fase temprana? Mencione al menos 4 aspectos

Comentado [A7]: Estas preguntas de apoyo dejar solo 2 que sean las más importantes en caso de ser útiles para despejar dudas.

¿Qué recomendaciones nos daría sobre la dosificación (frecuencia, duración, progresión e intensidad)?

4. Adherencia, educación y seguridad: ¿Qué recomendaciones educativas y de seguridad considera esenciales para que el plan sea aplicable y seguro tanto en la clínica como en la casa?

Comentado [A8]: Cambiar esta pregunta por: ha implementado ayudas o recursos tecnológicos en los planes de tratamiento orientados a la prevención de caídas en pacientes con Parkinson en fase temprana, Si/ No. Cuáles?

Preguntas de apoyo (solo si es necesario profundizar):

¿Cómo aborda el manejo del miedo a caer y la autoconfianza del paciente?

¿Qué participación debe tener el cuidador o la familia, qué deben saber hacer?

¿Cuáles son las barreras más típicas de adherencia (falta de motivación, tiempo) y cómo sugiere abordarlas?

5. Recomendaciones para el diseño de la guía: Pensando en la guía para fisioterapeutas que estamos desarrollando, ¿qué formato y recursos prácticos le serían más útiles para implementar este programa en su día a día?

Comentado [A9]: Modificar por: ¿conoce alguna guía de intervención que incluya recursos innovadores de tecnología para la intervención de los pacientes con Parkinson temprano para prevenir caídas, Si/No, mencione las guías o recursos que usted conoce

Preguntas de apoyo (solo si es necesario profundizar):

¿Le serviría encontrar herramientas como algoritmos de decisión, listas de chequeo o ejemplos de progresiones?

_____
_____

¿Qué errores comunes cree que debemos advertir en la guía para evitarlos?

_____
_____

¿Desea agregar algo que no hayamos preguntado y considere importante para prevenir caídas en Parkinson temprano desde nuestra profesión?

_____
_____

Comentado [A10]: Dejar solo dos, o incluso puede ser la última pregunta principal, que tipo de herramientas tecnológicas le gustaría encontrar en una guía de intervención dirigida a fisioterapeutas para prevenir caídas en pacientes con Parkinson en fase temprana. Puede profundizar con: y de estos nuevos complementos de tratamiento, usted estaría seguro o segura que puede implementarlo en su quehacer diario, Si/No, cuáles serían las principales razones (mencione 2).